

BAGIAN 1: KESEHATAN UMUM

1. PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI KESEHATAN

Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit. Kesehatan terbagi menjadi tiga tingkat: kesehatan primer (pencegahan penyakit dan promosi kesehatan), kesehatan sekunder (deteksi dini dan pengobatan), serta kesehatan tersier (rehabilitasi dan pemulihan). Berdasarkan usia, pasien diklasifikasikan menjadi balita (0-5 tahun) dengan sistem imun belum matang, anak-anak (6-12 tahun) yang aktif dan perlu pendampingan, remaja (13-18 tahun) yang sedang dalam masa pubertas, dewasa (19-59 tahun) yang produktif, dan lansia (≥ 60 tahun) yang mengalami penurunan fungsi tubuh. Tujuan perawatan kesehatan mencakup empat aspek utama: promotif yaitu meningkatkan derajat kesehatan melalui edukasi dan gaya hidup sehat, preventif yaitu mencegah penyakit melalui imunisasi dan skrining, kuratif yaitu menyembuhkan penyakit melalui pengobatan dan tindakan medis, serta rehabilitatif yaitu memulihkan fungsi tubuh setelah sakit atau operasi.

2. NUTRISI DAN GIZI SEIMBANG UNTUK SEMUA USIA

Prinsip Gizi Seimbang (Isi Piringku):

Setengah piring berisi sayur dan buah. Seperempat piring berisi protein hewani seperti ikan, ayam, telur, atau daging. Seperempat piring berisi protein nabati seperti tahu dan tempe serta karbohidrat.

Kebutuhan Kalori Harian:

Balita (1-3 tahun): 1.000-1.200 kkal, protein 15-20 gram

Anak-anak (4-9 tahun): 1.400-1.800 kkal, protein 25-35 gram

Remaja (10-18 tahun): 2.000-2.400 kkal, protein 45-55 gram

Dewasa (19-59 tahun): 2.000-2.500 kkal, protein 50-60 gram

Lansia (≥ 60 tahun): 1.800-2.000 kkal, protein 50-60 gram

Sumber Protein Hewani Terbaik:

Ikan laut (salmon, tuna, kembung): kaya omega-3 dan protein

Ayam tanpa kulit: protein tinggi, rendah lemak

Telur: protein lengkap, vitamin B

Daging sapi tanpa lemak: kaya zat besi

Susu dan produk olahan: tinggi kalsium

Sumber Protein Nabati Terbaik:

Tahu dan tempe: protein, kalsium, isoflavon

Kacang-kacangan (kedelai, kacang merah, kacang hijau): serat, protein

Edamame: protein, isoflavon

Sumber Karbohidrat Sehat:

Nasi merah: serat, vitamin B

Ubi jalar: vitamin A, serat

Oatmeal: serat larut, baik untuk jantung

Jagung: serat, antioksidan
Roti gandum: serat, vitamin B

Serat Harian:

20-30 gram per hari. Sumber: sayuran hijau (bayam, brokoli, kangkung), buah-buahan (apel, pir, pepaya, pisang), kacang-kacangan, biji-bijian (chia seed, flaxseed). Air putih: minimal 1,5-2 liter atau 6-8 gelas per hari.

Nutrisi Khusus Berdasarkan Kondisi:

Pasca operasi: protein tinggi (1,2-1,5 g/kg BB), vitamin C (200-500 mg/hari), zinc (15-30 mg/hari). Sumber: ikan, telur, jeruk, kacang.

Anemia: zat besi (10-15 mg/hari), vitamin B12, folat. Sumber: hati, bayam, kacang merah.

Diabetes: karbohidrat kompleks, serat. Sumber: nasi merah, oatmeal, sayuran.

Hipertensi: rendah garam (<5 gram/hari), tinggi kalium. Sumber: sayur, buah, ikan.

Luka bakar: protein tinggi (1,5-2,5 g/kg BB), kalori ekstra (35-40 kkal/kg BB). Sumber: telur, susu, ikan.

Imunitas rendah: vitamin C, zinc, probiotik. Sumber: jeruk, yogurt, kacang.

3. AKTIVITAS FISIK BERDASARKAN USIA

Rekomendasi WHO:

Balita: 180 menit/hari aktivitas ringan (bermain aktif, merangkak, jalan)

Anak-anak: 60 menit/hari aktivitas sedang-berat (bermain, olahraga, lari)

Remaja: 60 menit/hari aktivitas sedang-berat (olahraga, aerobik, kekuatan)

Dewasa: 150-300 menit/minggu aktivitas sedang (jalan cepat, bersepeda, renang)

Lansia: 150 menit/minggu aktivitas ringan-sedang (jalan, senam, yoga)

Jenis Latihan Berdasarkan Tujuan:

Kesehatan jantung (aerobik): jalan cepat, renang, bersepeda. Frekuensi: 5x/minggu.

Kekuatan otot (resistance): angkat beban, push-up, squat. Frekuensi: 2-3x/minggu.

Fleksibilitas (stretching): peregangan, yoga. Frekuensi: setiap hari.

Keseimbangan (balance): berdiri satu kaki, tai chi. Frekuensi: setiap hari.

Tulang (weight-bearing): jalan, lari, lompat tali. Frekuensi: 3-4x/minggu.

Tanda Bahaya Olahraga (Hentikan dan Konsultasi):

Nyeri dada, sesak napas berat, pusing atau pingsan, jantung berdebar tidak teratur, nyeri sendi atau otot yang memberat.

Tips Aman Berolahraga:

Pemanasan 5-10 menit sebelum olahraga, pendinginan 5-10 menit setelah olahraga, minum air sebelum, selama, dan setelah olahraga, gunakan pakaian dan alas kaki yang sesuai, tidak memaksakan diri.

4. PENCEGAHAN PENYAKIT UMUM

Penyakit Tidak Menular (PTM):

Hipertensi: faktor risiko garam berlebih, stres, obesitas. Pencegahan: kurangi garam (<5 gram/hari), olahraga teratur, cek tekanan darah rutin setiap bulan. Target tekanan darah: <120/80 mmHg.

Diabetes: faktor risiko gula berlebih, kurang gerak, genetik. Pencegahan: kontrol gula darah, makan teratur 3x sehari, olahraga teratur, cek gula darah setiap 3-6 bulan. Target gula darah puasa: <100 mg/dL, gula darah 2 jam setelah makan: <180 mg/dL, HbA1c: <7%.

Jantung Koroner: faktor risiko lemak jenuh, merokok, hipertensi. Pencegahan: diet sehat rendah lemak jenuh, tidak merokok, cek kolesterol setiap tahun. Target LDL: <100 mg/dL.

Stroke: faktor risiko hipertensi, diabetes, merokok. Pencegahan: kontrol tekanan darah, gaya hidup sehat, deteksi dini gejala stroke.

Kanker: faktor risiko rokok, alkohol, obesitas, genetik. Pencegahan: deteksi dini melalui skrining rutin, gaya hidup sehat.

Osteoporosis: faktor risiko kurang kalsium, kurang gerak, usia lanjut. Pencegahan: asupan kalsium 1.000-1.200 mg/hari, vitamin D 800-1.000 IU/hari (jemur pagi 10-15 menit), olahraga beban.

Pemeriksaan Kesehatan Rutin:

Tekanan darah: setiap bulan, target <120/80 mmHg.

Gula darah: setiap 3-6 bulan, target puasa <100 mg/dL.

Kolesterol: setiap tahun, target LDL <100 mg/dL.

Berat badan: setiap bulan, target IMT 18,5-24,9.

Mata: setiap 1-2 tahun.

Gigi: setiap 6 bulan.

Vaksinasi Dewasa:

Influenza: setiap tahun.

Pneumonia: 1-2 kali seumur hidup (usia ≥65 tahun atau risiko tinggi).

Tetanus-Difteri: setiap 10 tahun.

Hepatitis B: 3 dosis (risiko tinggi).

HPV: 2-3 dosis (usia 9-45 tahun).

COVID-19: sesuai rekomendasi.

5. KESEHATAN MENTAL

Gangguan Mental:

Depresi: gejala sedih >2 minggu, kehilangan minat, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, penurunan energi. Penanganan: konsultasi psikolog/psikiater, terapi kognitif perilaku, dukungan sosial.

Kecemasan: gejala gelisah, takut berlebihan, jantung berdebar, sulit konsentrasi. Penanganan: teknik relaksasi, latihan pernapasan, konsultasi profesional.

Stres: gejala mudah marah, sulit konsentrasi, lelah, gangguan tidur. Penanganan: manajemen stres, olahraga teratur, keseimbangan hidup.

Insomnia: gejala sulit tidur, sering terbangun, terbangun terlalu pagi. Penanganan: rutinitas tidur konsisten, hindari gadget 1 jam sebelum tidur, lingkungan tidur nyaman.

Teknik Relaksasi Pernapasan Dalam:

Duduk tegak, tutup mata. Tarik napas melalui hidung (hitung 4), tahan napas (hitung 4), hembuskan perlahan melalui mulut (hitung 6). Ulangi 5-10 kali.

Teknik Mindfulness:

Fokus pada saat ini, amati pikiran tanpa menghakimi, latihan 5-10 menit setiap hari.

BAGIAN 2: PERAWATAN PASCA OPERASI

6. KLASIFIKASI OPERASI

Berdasarkan Urgensi:

Elektif: dijadwalkan, tidak darurat (katarak, hernia, persalinan normal).

Semi-elektif: perlu ditangani dalam waktu tertentu (tumor jinak, batu ginjal).

Darurat: harus segera ditangani (apendisitis, patah tulang terbuka).

Emergensi: mengancam nyawa (perdarahan internal, trauma berat).

Berdasarkan Tingkat Kontaminasi:

Kelas I (Bersih): tanpa infeksi, tidak masuk saluran cerna/pernapasan (jantung, ortopedi, mata).

Risiko infeksi: <2%.

Kelas II (Bersih Terkontaminasi): masuk saluran cerna/pernapasan tanpa kontaminasi signifikan (usus, kandung empedu). Risiko infeksi: 5-10%.

Kelas III (Terkontaminasi): kontaminasi signifikan, trauma terbuka <4 jam (trauma, kebocoran usus). Risiko infeksi: 15-20%.

Kelas IV (Kotor): infeksi aktif, trauma >4 jam (abses, perforasi usus). Risiko infeksi: >25%.

Tahapan Pasca Operasi:

Fase I (Pemulihan): 0-2 jam, fokus pulih dari anestesi, lokasi ruang pemulihan.

Fase II (Awal): 2-48 jam, fokus stabilisasi, manajemen nyeri, lokasi ruang rawat.

Fase III (Perawatan): 3-14 hari, fokus perawatan luka, mobilisasi, lokasi ruang rawat/rumah.

Fase IV (Rehabilitasi): 2-6 minggu, fokus pemulihan fungsi, aktivitas bertahap, lokasi rumah.

Fase V (Kembali Normal): >6 minggu, fokus aktivitas normal, kontrol rutin, lokasi rumah.

7. MANAJEMEN NYERI PASCA OPERASI

Skala Nyeri Numerik (0-10):

0: tidak ada nyeri.

1-3: nyeri ringan, masih bisa diabaikan.

4-6: nyeri sedang, mengganggu aktivitas.

7-9: nyeri berat, tidak bisa tidur.

10: nyeri sangat berat, tidak tertahankan.

Manajemen Nyeri Non-Farmakologi:

Kompres dingin: 24-48 jam pertama, 15-20 menit setiap 2-3 jam. Fungsi: kurangi bengkak, mati rasa.

Kompres hangat: setelah 48 jam, 15-20 menit setiap 3-4 jam. Fungsi: relaksasi otot.

Elevasi: meninggikan area operasi 24-48 jam. Fungsi: kurangi bengkak.

Teknik relaksasi: napas dalam, visualisasi, 5-10 menit. Fungsi: kurangi stres.

Distraksi: musik, video, bacaan sesuai kebutuhan. Fungsi: alihkan fokus dari nyeri.

Aromaterapi: lavender, peppermint, 15-30 menit. Fungsi: relaksasi.

Manajemen Nyeri Farmakologi:

Paracetamol (analgesik non-opioid): dosis 500 mg, 3-4x/hari. Indikasi: nyeri ringan-sedang.

Efek samping: hati-hati gangguan hati.

Ibuprofen, Ketorolac (NSAID): dosis 400 mg, 3x/hari (setelah makan). Indikasi: nyeri inflamasi.

Efek samping: lambung, ginjal.

Tramadol (opioid ringan): dosis 50-100 mg, 3-4x/hari. Indikasi: nyeri sedang. Efek samping: kantuk, mual, konstipasi.

Morfin, Fentanyl (opioid kuat): sesuai resep dokter. Indikasi: nyeri berat. Efek samping: depresi napas, adiksi.

Lidocaine patch (anestesi lokal): sesuai resep. Indikasi: nyeri lokal. Efek samping: iritasi kulit.

Gabapentin, Amitriptyline (ko-analgesik): sesuai resep. Indikasi: nyeri neuropatik. Efek samping: kantuk, pusing.

Algoritma Manajemen Nyeri:

Nyeri ringan (1-3): paracetamol 500 mg + kompres hangat/dingin + relaksasi. Evaluasi 30 menit.

Nyeri sedang (4-6): paracetamol + NSAID + elevasi + distraksi. Jika tidak membaik, tambah tramadol.

Nyeri berat (7-10): opioid (tramadol/morfin) + konsultasi dokter + evaluasi penyebab nyeri.

8. PERAWATAN LUKA OPERASI

Jenis Penutup Luka:

Kasa kering: untuk luka kering, jahitan. Kelebihan: murah, mudah. Kekurangan: melekat pada luka.

Kasa NaCl: untuk luka basah. Kelebihan: bersih, tidak melekat. Kekurangan: perlu sering ganti.

Hydrocolloid: untuk luka bersih, sedikit eksudat. Kelebihan: tahan air, lama. Kekurangan: mahal.

Foam dressing: untuk eksudat sedang-berat. Kelebihan: menyerap baik. Kekurangan: tidak transparan.

Film transparan: untuk luka kering, monitoring. Kelebihan: lihat luka. Kekurangan: tidak menyerap.

Alginate: untuk eksudat berat. Kelebihan: menyerap banyak. Kekurangan: perlu balutan sekunder.

Teknik Ganti Balutan:

Persiapan: cuci tangan dengan sabun 20 detik, siapkan alat (kasa steril, NaCl, plester, sarung tangan), pastikan pencahayaan cukup.

Prosedur: pakai sarung tangan bersih, lepas balutan lama hati-hati, lihat tanda infeksi (kemerahan, bengkak, nanah), basahi kasa dengan NaCl 0,9%, bersihkan luka dari tengah ke tepi (sekali usap), keringkan dengan tepuk lembut (jangan digosok), oleskan salep jika diresepkan, tutup dengan kasa steril baru, rekatkan dengan plester.

Frekuensi: luka bersih setiap 1-2 hari, luka basah setiap hari, luka infeksi 2-3 kali sehari.

Tanda Infeksi Luka (Segera ke Dokter):

Kemerahan: meluas >2 cm dari tepi luka.

Bengkak: membesar, terasa hangat.

Nyeri: bertambah hebat.

Nanah: cairan kental kuning/hijau, berbau.

Demam: suhu >38°C.

Jahitan lepas: luka terbuka, menganga.

Perawatan Luka Kering (Jahitan/Stapler):

Jaga luka kering 24-48 jam pertama. Setelah itu boleh kena air (keringkan segera). Jangan merendam luka (mandi bak, berenang) sampai jahitan dilepas. Jangan menggaruk atau mengelupas keropeng.

9. NUTRISI PASCA OPERASI

Tahapan Pemberian Makan:

Fase I (Cair Jernih): 0-24 jam. Jenis: air, kaldu bening, teh, agar-agar.

Fase II (Cair Penuh): 24-48 jam. Jenis: susu, jus tanpa ampas, sup krim.

Fase III (Lunak): 3-14 hari. Jenis: bubur, ikan kukus, telur rebus.

Fase IV (Transisi): 2-4 minggu. Jenis: nasi tim, sayur cincang.

Fase V (Normal): >4 minggu. Jenis: kembali ke pola normal.

Kebutuhan Nutrisi Berdasarkan Jenis Operasi:

Bedah umum: protein 1,0-1,2 g/kg BB, kalori 25-30 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: vitamin C, zinc.

Bedah digestif: protein 1,2-1,5 g/kg BB, kalori 30-35 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: probiotik, serat bertahap.

Bedah ortopedi: protein 1,2-1,5 g/kg BB, kalori 30-35 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: kalsium, vitamin D.

Bedah jantung: protein 1,2-1,5 g/kg BB, kalori 25-30 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: omega-3, rendah lemak.

Bedah onkologi: protein 1,5-2,0 g/kg BB, kalori 30-35 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: antioksidan tinggi.

Luka bakar: protein 1,5-2,5 g/kg BB, kalori 35-40 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: vitamin A, C, zinc.

Transplantasi: protein 1,2-1,5 g/kg BB, kalori 30-35 kkal/kg BB. Nutrisi khusus: imunonutrisi.

Makanan Dianjurkan:

Protein tinggi: ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, susu, yogurt.

Antioksidan tinggi: jeruk, kiwi, tomat, brokoli, blueberry, wortel.

Lemak sehat: alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, ikan berlemak.

Makanan Dihindari:

Gorengan: 2 minggu (sulit dicerna, peradangan).

Pedas: 2 minggu (iritasi lambung).

Asam: 2 minggu (iritasi lambung).

Berserat tinggi: 1 minggu (sulit dicerna).

Susu sapi: 1 minggu (gas, kembung jika intoleransi).

Alkohol: 4 minggu (interaksi obat, gangguan penyembuhan).

Gula berlebih: selama pemulihan (hambat sistem imun).

10. MOBILISASI DAN REHABILITASI

Panduan Mobilisasi Berdasarkan Operasi:

Apendisitis: duduk 4-6 jam, berdiri 6-8 jam, jalan 8-12 jam, angkat beban 2-3 minggu.

Hernia: duduk 4-6 jam, berdiri 6-8 jam, jalan 8-12 jam, angkat beban 4-6 minggu.

Kandung empedu: duduk 4-6 jam, berdiri 6-8 jam, jalan 8-12 jam, angkat beban 2-3 minggu.

Usus besar: duduk 1-2 hari, berdiri 2-3 hari, jalan 3-4 hari, angkat beban 4-6 minggu.

Jantung (bypass): duduk 1-2 hari, berdiri 2-3 hari, jalan 3-4 hari, angkat beban 6-8 minggu.

Caesar: duduk 8-12 jam, berdiri 12-24 jam, jalan 24 jam, angkat beban 6-8 minggu.

Katarak: duduk segera, berdiri 1 jam, jalan 2 jam, angkat beban 2-3 minggu.

Panggul (THR): duduk 1 hari, berdiri (alat) 1-2 hari, jalan (alat) 2-3 hari, angkat beban 6-8 minggu.

Teknik Log Roll (Berguling Aman):

Tekuk lutut kedua kaki, miring ke sisi tempat tidur (gulung badan), turunkan kaki perlahan ke lantai, dorong badan dengan tangan, duduk 1-2 menit sebelum berdiri, berdiri perlahan sambil berpegangan.

Teknik Berjalan dengan Alat Bantu:

Walker: berdiri di dalam walker, dorong ke depan, langkahkan kaki sakit lebih dulu, diikuti kaki sehat.

Tongkat: pegang di sisi berlawanan dengan kaki sakit, langkahkan tongkat dan kaki sakit bersamaan, langkahkan kaki sehat ke depan.

Kruk: tumpuan pada lengan, langkahkan kaki sehat lebih dulu, diikuti kruk dan kaki sakit.

Latihan Pernapasan (Teknik Diafragma):

Duduk tegak atau setengah duduk, letakkan satu tangan di perut, tarik napas dalam melalui hidung (hitung 3) sambil merasakan perut mengembang, tahan 3 detik, hembuskan perlahan melalui mulut (hitung 6) sambil merasakan perut mengempis. Ulangi 5-10 kali setiap 1-2 jam.

Teknik Batuk Efektif:

Duduk tegak, tarik napas dalam, topang luka dengan bantal atau tangan, batuk dengan mulut terbuka. Ulangi 2-3 kali.

Program Rehabilitasi Jantung:

Fase I (RS): latihan napas, mobilisasi dini, edukasi.

Fase II (2-12 minggu): walking program, latihan beban ringan, monitoring.

Fase III (3-6 bulan): latihan intensitas sedang, aktivitas sehari-hari.

Fase IV (>6 bulan): pemeliharaan, aktivitas normal.

Program Rehabilitasi Ortopedi:

Fase I (0-2 minggu): kontrol nyeri, latihan gerak pasif, tidak menahan beban.

Fase II (2-6 minggu): latihan gerak aktif, menahan beban bertahap.

Fase III (6-12 minggu): latihan kekuatan, koordinasi.

Fase IV (>12 minggu): latihan fungsional, olahraga.

11. KOMPLIKASI PASCA OPERASI

Komplikasi Umum dan Penanganan:

Infeksi luka: gejala kemerahan, bengkak, nanah, demam. Penyebab kontaminasi. Penanganan: antibiotik, perawatan luka.

Perdarahan: gejala luka basah, darah segar, syok. Penyebab pembuluh darah tidak tertutup.

Penanganan: tekan luka, segera IGD.

Hematoma: gejala bengkak kebiruan, nyeri. Penyebab perdarahan tertutup. Penanganan: kompres dingin, observasi.

DVT: gejala satu kaki bengkak tidak simetris, nyeri betis. Penyebab imobilisasi, dehidrasi.

Penanganan: antikoagulan, segera IGD.

Pneumonia: gejala batuk, demam, sesak napas. Penyebab imobilisasi, napas dangkal.

Penanganan: latihan napas, antibiotik.

Sembelit: gejala tidak BAB >3 hari. Penyebab opioid, kurang gerak. Penanganan: air, serat, pencahar.

Retensi urine: gejala tidak BAK >8 jam. Penyebab anestesi, nyeri. Penanganan: relaksasi, kateter.

Ileus: gejala perut kembung, tidak flatus. Penyebab operasi perut. Penanganan: puasa sementara, cairan.

Delirium: gejala bingung, gelisah, halusinasi. Penyebab anestesi, elektrolit. Penanganan: reorientasi, obat.

Deep Vein Thrombosis (DVT) - Pencegahan:

Faktor risiko: operasi >45 menit, imobilisasi >3 hari, usia >60 tahun, obesitas, riwayat DVT, kanker, kehamilan.

Pencegahan: mobilisasi dini, latihan pompa kaki (gerakkan pergelangan), minum air 1,5-2 liter/hari, stocking kompresi (jika disarankan), antikoagulan profilaksis (risiko tinggi).

Tanda bahaya DVT: satu kaki bengkak tidak simetris, nyeri betis saat digerakkan, warna kemerahan atau kebiruan, terasa hangat pada area betis. **SEGERA KE IGD.**

Emboli Paru - Tanda Bahaya:

Sesak napas mendadak, nyeri dada tajam, batuk darah, jantung berdebar, pingsan. **SEGERA KE IGD.**

Kapan Harus Segera ke IGD:

Sesak napas mendadak, nyeri dada menjalar ke lengan/rahang, perdarahan aktif tidak berhenti, demam >38,5°C tidak turun dengan obat, luka terbuka lebar/jahitan terlepas, nyeri hebat tidak tertahan obat, pingsan atau kejang, sulit bicara atau gerak separuh tubuh, muntah darah atau BAB hitam, satu kaki bengkak dengan nyeri.

12. PERAWATAN BERDASARKAN JENIS OPERASI

Pasca Operasi Jantung:

Larangan: angkat beban >5 kg selama 6 minggu, menyetir 4-6 minggu, mandi bak/berendam 2 minggu.

Keharusan: ikuti program rehabilitasi jantung, kontrol tekanan darah (<130/80 mmHg), kontrol gula darah (jika diabetes).

Tanda bahaya: nyeri dada seperti ditekan, sesak napas saat aktivitas ringan, jantung berdebar tidak teratur, pusing mendadak atau pingsan, bengkak kaki mendadak.

Pasca Operasi Ortopedi (Panggul/THR):

Pencegahan dislokasi: tidak menyilangkan kaki, duduk di kursi tinggi, tidak membungkuk >90°, tidur dengan bantal di antara lutut, gunakan toilet seat tinggi, tidak memutar tubuh dengan kaki tetap.

Perawatan: ikuti protokol fisioterapi, gunakan alat bantu sampai instruksi dilepas, tidak berhenti bergerak, jaga berat badan ideal, latihan gerak sendi setiap hari.

Pasca Operasi Perut:

Perawatan: hindari batuk/bersin keras (topang luka dengan bantal), jangan angkat >5 kg selama 4-6 minggu, makan perlahan porsi kecil tapi sering, konsumsi serat bertahap, hindari berbaring telentang terlalu lama.

Aturan batuk: tekuk lutut, topang luka dengan kedua tangan atau bantal, batuk pelan dengan mulut terbuka, lakukan latihan napas dalam.

Pasca Operasi Mata (Katarak):

Perawatan: jangan menunduk/membungkuk 1 minggu, jangan mengucek/menekan mata, pakai pelindung mata saat tidur 1 minggu, tetes mata sesuai jadwal, hindari debu/asap/air keruh, jangan mengemudi sampai izin dokter.

Larangan: tidak membaca/melihat layar >15 menit (3 hari pertama), tidak angkat >5 kg (2 minggu), hindari kontak air sabun (1 minggu).

Pasca Operasi Caesar:

Perawatan: jangan angkat >5 kg (termasuk anak) selama 6 minggu, hindari aktivitas berat dan seksual 6 minggu, gunakan binder perut jika nyaman, tidur miring kiri/kanan, jaga kebersihan luka dan keringkan setelah mandi.

Aktivitas: mobilisasi dini (8-12 jam) untuk mencegah DVT, jalan kaki ringan mulai 24 jam, hindari menaiki tangga terlalu sering.

13. DUKUNGAN PSIKOLOGIS PASCA OPERASI

Reaksi Emosional Normal:

Kecemasan: takut nyeri, takut komplikasi, takut hasil operasi. Penanganan: informasi jelas, latihan relaksasi, dukungan emosional.

Kesedihan: kehilangan kemandirian, perubahan fisik, keterbatasan aktivitas. Penanganan: validasi perasaan, libatkan dalam aktivitas, apresiasi kemajuan.

Frustrasi: pemulihan terasa lambat. Penanganan: target kecil realistis, apresiasi kemajuan, ingatkan pemulihan butuh waktu.

Insomnia: nyeri, cemas, lingkungan asing. Penanganan: manajemen nyeri, rutinitas tidur konsisten, lingkungan tidur nyaman.

Cara Mendukung Mental Pasien:

Validasi perasaan: "Wajar merasa khawatir, ini bagian dari proses."

Libatkan dalam keputusan: tanya pendapat tentang jadwal terapi.

Berikan kabar positif: "Hari ini lukanya lebih baik dari kemarin."

Fasilitasi aktivitas disukai: bawa buku, mainan, atau gadget.

Pastikan dukungan sosial: ajak keluarga atau teman mengunjungi.

Kapan Perlu Konsultasi Psikolog:

Depresi >2 minggu, tidak mau makan/minum, menarik diri dari interaksi, ingin menyakiti diri sendiri, gelisah berlebihan.

14. PERSIAPAN PULANG DARI RUMAH SAKIT

Perlengkapan Perawatan Luka:

Kasa steril (10-20 lembar), plester luka, NaCl 0,9% (1-2 botol), kapas dan sarung tangan sekali pakai, tempat sampah medis, salep luka (jika diresepkan).

Perlengkapan Mobilisasi:

Kursi toilet tinggi (jika perlu), alat bantu jalan (walker/tongkat), alas anti-slip di kamar mandi, pegangan di samping tempat tidur, kursi mandi (jika perlu).

Perlengkapan Monitoring:

Termometer digital, tensi meter (jika perlu), buku catatan kontrol, jam alarm untuk jadwal obat.

Pertanyaan yang Harus Ditanyakan ke Dokter:

Kapan jadwal kontrol dan bagaimana cara mendaftar?

Obat apa saja yang harus diminum? Aturannya bagaimana?

Kapan luka bisa terkena air?

Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah?

Kapan bisa kembali bekerja/beraktivitas normal?

Tanda bahaya apa yang harus saya waspadai?

Nomor telepon siapa yang bisa dihubungi jika ada masalah?

15. PANDUAN HARIAN CAREGIVER

Jadwal Aktivitas Harian:

Pagi (06:00-09:00): bangunkan dengan lembut, bantu cuci muka dan sikat gigi, cek tanda vital (suhu, tensi), bantu minum obat pagi, siapkan sarapan tinggi protein.

Siang (09:00-14:00): cek luka (kemerahan, kebasahan), ganti balutan jika perlu, bantu mobilisasi (jalan ringan), siapkan makan siang seimbang, pantau nyeri (skala 0-10).

Sore (14:00-18:00): cek tanda-tanda infeksi, bantu latihan pernapasan, lakukan aktivitas ringan (baca, ngobrol), bantu mandi (jika sudah boleh).

Malam (18:00-21:00): siapkan makan malam ringan, bantu minum obat malam, cek kulit area yang tertekan, pastikan lingkungan aman (penerangan cukup), bantu persiapan tidur.

Tips untuk Caregiver:

Istirahat cukup (minimal 6 jam/hari), makan teratur dan bergizi, minta bantuan keluarga lain jika lelah, jangan ragu konsultasi dengan tim medis, catat perkembangan pasien untuk dilaporkan ke dokter.

Disclaimer:

Informasi ini bersumber dari Kemenkes RI, IDI, PERSI, dan protokol medis terkini. Konten ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak menggantikan saran medis profesional. Setiap tindakan medis harus dikonsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan yang menangani pasien. Untuk keadaan darurat, segera hubungi layanan gawat darurat (119 atau IGD terdekat).

CARA REGISTRASI LAYANAN KESEHATAN

Registrasi Online melalui Website:

Langkah pertama adalah mengunjungi website resmi penyedia layanan kesehatan. Klik menu "Daftar" atau "Registrasi" yang tersedia di halaman utama. Isi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap seperti nama lengkap sesuai KTP, nomor identitas (NIK), tanggal lahir, alamat

lengkap, nomor telepon aktif, dan alamat email. Setelah itu, pilih jenis layanan yang dibutuhkan seperti konsultasi umum, konsultasi spesialis, perawatan pasca operasi, homecare, atau pemeriksaan kesehatan rutin. Pilih jadwal yang diinginkan dari kalender yang tersedia, kemudian lakukan verifikasi data dan konfirmasi pendaftaran. Sistem akan mengirimkan kode booking atau nomor antrean melalui email atau WhatsApp.

Registrasi melalui Aplikasi Mobile:

Unduh aplikasi resmi dari Play Store atau App Store. Setelah terinstal, buka aplikasi dan pilih "Daftar Akun Baru". Masukkan nomor telepon aktif untuk menerima kode verifikasi OTP. Setelah kode terverifikasi, lengkapi profil dengan data diri, riwayat kesehatan, alergi obat, dan data penanggung jawab atau keluarga. Pilih layanan yang diinginkan dan lakukan booking jadwal. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, e-wallet (GoPay, OVO, Dana), atau virtual account. Setelah pembayaran dikonfirmasi, Anda akan menerima tiket konsultasi atau jadwal kunjungan perawat.

Registrasi melalui WhatsApp Chatbot:

Simpan nomor layanan customer service, lalu kirim pesan dengan format "Halo, saya ingin registrasi". Ikuti panduan yang diberikan chatbot untuk mengisi data diri. Chatbot akan meminta informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan jenis layanan yang dibutuhkan. Setelah data lengkap, chatbot akan memberikan pilihan jadwal yang tersedia. Pilih jadwal yang sesuai, lalu lakukan konfirmasi. Pembayaran dapat dilakukan melalui tautan yang dikirimkan. Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima kartu registrasi digital.

Registrasi Manual di Fasilitas Kesehatan:

Datang langsung ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Ambil formulir pendaftaran di loket pendaftaran. Isi formulir dengan data diri lengkap. Serahkan formulir beserta fotokopi KTP dan kartu BPJS jika ada. Petugas akan memberikan nomor antrean dan mengarahkan ke poli atau ruang perawatan yang dituju. Pastikan membawa dokumen pendukung seperti rujukan dari dokter sebelumnya, hasil laboratorium, atau riwayat pengobatan.